Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Lajeado

Rua Paulo Frederico Schumacher, 77 - Bairro: Moinhos - CEP: 95900780 - Fone: (51) 3710-1500 - Email: frlajeado2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5005666-49.2021.8.21.0017/RS

AUTOR: VICTORIA ROCKENBACH CHIMENDES
RÉU: UNIMED VALE DO TAQUARI E RIO PARDO

SENTENÇA

Vistos etc.

VICTORIA ROCKENBACH CHIMENDES, já qualificada, ingressou com **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA** em face da **UNIMED VALE DO TAQUARI E RIO PARDO,** igualmente qualificada. Disse que está grávida de 10 semanas tendo descoberto que sofre de TROMBOFILIA (alteração alfa metil redutase), doença que possibilita a interrupção da gestação, bem como risco de morte à parturiente. Referiu que, em face desta situação, necessita ser tratada com a solução injetável denominada ENOXOPARINA 40mg, durante toda a gestação e 06 semanas após o parto, mas cujo custo mensal – em torno de R$ 1.351,29 – não tem condições de suportar. Asseverou que em contato com a ré, com a qual mantém Plano de Saúde, esta se negou à cobertura do medicamento prescrito sob alegação de que o medicamento estaria excluído do contrato, razão do ingresso com o presente feito. Requereu, em tutela antecipada, que a ré procedesse no custeio de todo o tratamento de TROMBOFILIA, durante toda sua gestação e 06 semanas após o parto – com a medicação Enoxoparina 40MG ou outra dosagem que viesse a ser solicitada por indicação médica; e, no mérito, a procedência do feito com a confirmação da medida. Requereu, ainda, AJG, bem como a inversão do ônus da prova. Atribuiu à causa o valor de R$10.810,32. Juntou documentos.

No evento 8 foi deferida a tutela antecipada, concedida AJG e invertido o ônus da prova.

Da decisão, restou interposto agravo de instrumento (evento 21), sendo o mesmo recebido no efeito suspensivo.

Citada, a ré contestou o feito (evento 18) defendendo que o contrato é claro ao referir que o risco assumido corresponde tão somente ao que está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, atualmente definido através dos Anexos I e II da Resolução Normativa nº. 428, de 07 de fevereiro de 2017 (RN nº. 428/ 2017), da ANS. Referiu que o contrato possui expressa previsão de exclusão de cobertura para os tratamentos não elencados no rol de procedimentos da ANS, conforme dispõe a Cláusula 12, inciso XIV, do referido contrato e que o medicamento postulado pela parte autora não está elencado no Rol da ANS, postulando a improcedência do feito.

Houve réplica (evento 26).

Julgado o agravo de instrumento, o mesmo foi provido, determinando a revogação da tutela de urgência conferida.

Intimadas sobre as provas (evento 29), a parte autora requereu o julgamento do feito (evento 34) e a ré quedou-se inerte.

Os autos, então, vieram conclusos para sentença.

É O RELATO.

DECIDO.

Trata-se de ação que almeja a parte autora seja determinado ao réu o cumprimento de obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg para o correto enfrentamento de trombofilia.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Aliás, este é o entendimento da Súmula 608 do STJ[1].

Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do Código de Defesa do Consunidor, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso em análise, resta incontroversa a contratação do plano de saúde (evento 18, CONTR2) bem como o diagnóstico de Trombofilia e a recomendação médica para uso do medicamento Enoxaparina durante a gravidez e 06 semanas após o parto (evento 1, LAUDO8 e evento 26, OUT2).

De outro viés, a alegação da parte ré é de que o referido medicamento estaria excluído de cobertura para os tratamentos não elencados no rol de procedimentos da ANS, conforme dispõe a Cláusula 12, inciso XIV.

No entanto, descabe a negativa. Isso porque o tratamento foi recomendado pela médica assistente da autora (evento 1, LAUDO8 e evento 26, OUT2), indicando que esta deve fazer uso contínuo de doses de enoxaparina ao longo de toda a gestação e 06 semanas após o parto. Assim, considerando a indicação médica, necessária se mostra a cobertura do tratamento, pois se está a tratar de um bem de hierarquia superior que é a saúde humana.

Outrossim, além do princípio da boa-fé entre as partes, o plano ou seguro de saúde não pode, segundo o previsto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem.

A propósito, um dos elementos essenciais do contrato de prestação de serviços médicos é a boa-fé entre os contratantes, prevista no art. 422 do Código Civil vigente[2].

Além disso, o que importa é a existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora, não importando a forma como o tratamento será ministrado.

Nessa linha, os seguintes precedentes jurisprudenciais:

*APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDE E MUTAÇÃO DO FATOR V DA PROTROMBINA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO ENOXAPARINA. DEVER DE COBERTURA VERIFICADO. 1. INCIDE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, SALVO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º, §2º, BEM COMO PELO QUE DISPÕE A SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 35 DA LEI Nº 9.656/1998. **2. AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR PLANOS DE SAÚDE SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI.** NÃO OBSTANTE, EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10. 3. NO PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE PUBLICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR É TÃO SOMENTE REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NÃO POSSUINDO CARÁTER TAXATIVO. 4. RESSALTE-SE, OUTROSSIM, QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, É FACULTADO AOS PLANOS DE SAÚDE ESTABELECEREM PARA QUAIS PATOLOGIAS IRÃO OFERECER COBERTURA; NO ENTANTO, NÃO PODEM LIMITAR O TRATAMENTO, POIS ESTE CABE SOMENTE AO MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE SEGURADO, CONHECEDOR DAS PECULIARIDADES DE SEU QUADRO CLÍNICO. **5. NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS, HAVENDO LAUDO MÉDICO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR COM O MEDICAMENTO POSTULADO NA EXORDIAL (ENOXAPARINA), TEM-SE COMO DEVIDO O FORNECIMENTO DA ALUDIDA MEDICAÇÃO, SENDO IRRELEVANTE, NO CASO, O LOCAL ONDE SERÁ MINISTRADO O FÁRMACO.** 6. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, EM ATENÇÃO AO PRECONIZADO PELO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50019545120218210017, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 25-05-2022 - grifei)*

*APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TROMBOFILIA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO ENOXAPARINA. DEVER DE COBERTURA VERIFICADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO INDENIZATÓRIO. INTEPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA EXORDIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. 1. INCIDE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, SALVO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º, §2º, BEM COMO PELO QUE DISPÕE A SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 35 DA LEI Nº 9.656/1998. 2. AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR PLANOS DE SAÚDE SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI. NÃO OBSTANTE, EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10. 3. NO PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, **O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE PUBLICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR É TÃO SOMENTE REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE, NÃO POSSUINDO CARÁTER TAXATIVO.** 4. RESSALTA-SE, OUTROSSIM, QUE, TAMBÉM DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, É FACULTADO AOS PLANOS DE SAÚDE ESTABELECEREM PARA QUAIS PATOLOGIAS IRÃO OFERECER COBERTURA; NO ENTANTO, NÃO PODEM LIMITAR O TRATAMENTO, POIS ESTE CABE SOMENTE AO MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE SEGURADO, CONHECEDOR DAS PECULIARIDADES DE SEU QUADRO CLÍNICO. 5. NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS, **HAVENDO LAUDO MÉDICO QUE DEMONSTRE A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR COM O MEDICAMENTO POSTULADO NA EXORDIAL (ENOXAPARINA), TEM-SE COMO DEVIDO O FORNECIMENTO DA ALUDIDA MEDICAÇÃO, SENDO IRRELEVANTE, NO CASO, O LOCAL ONDE SERÁ MINISTRADO O FÁRMACO.** (...)APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível, Nº 50024432520208210017, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-04-2022 - grifei)*

*PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO OU OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. **MATERIAIS DEVIDAMENTE PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.** SÚMULA N. 83 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. VALOR FINAL PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.*

1. O conhecimento do recurso especial exige a indicação do dispositivo legal supostamente violado ou objeto da alegada divergência jurisprudencial. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.

2. É abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamente ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato. Precedentes.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. Correta a decisão que, ao negar provimento ao agravo nos próprios autos, majorou em 20% (vinte por cento) o valor dos honorários advocatícios, nos estritos limites do art. 85, § 11, do CPC/2015, levando em conta os requisitos previstos nos incisos I a IV do § 2º do mesmo dispositivo. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1715583/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020 - grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO IMPORTADO. AVASTIN. REGISTRO. ANVISA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL À RECUPERAÇÃO DO PACIENTE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação ordinária que visa a cobertura de tratamento quimioterápico com medicamento (Avastin) registrado na ANVISA desde 16/5/2005.

3. A exclusão da cobertura do produto farmacológico nacionalizado e indicado pelo médico assistente, de uso ambulatorial ou hospitalar e sem substituto eficaz para o tratamento da enfermidade, significa negar a própria essência do tratamento,

desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde (arts. 35-F da Lei nº 9.656/1998 e 7º, parágrafo único, e 17 da RN nº 387/2015 da ANS).
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1555404/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020 - grifei)

AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. TROMBOFILIA HEREDITÁRIA. TRATAMENTO DOMICILIAR. MEDICAMENTO ENOXOPARINA – CLEXEANE. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. No caso, a autora é portadora de trombofilia hereditária (CID 10 D68.8) e já sofreu processo tromboembólico prévio, necessitando, em função destes fatos e de estar gestando, utilizar o medicamento Enoxoparina - Clexeane 40mg diariamente até 15 dias após o parto, cuja cobertura para o fornecimento do medicamento para uso domiciliar foi negada pela operadora do plano de saúde. II. Contudo, os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 608, do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação. ***De outro lado, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, ainda que não esteja previsto no Rol de Procedimentos da ANS, o qual é meramente exemplificativo, conforme entendimento do egrégio STJ, ou não preenchida a Diretriz de Utilização, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.*** *III. Nessa linha, conforme entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o local da administração do medicamento é irrelevante para definir o dever de cobertura pelo plano de saúde. Em outras palavras, se há cobertura para a doença, deve ser fornecido o medicamento ministrado pelo médico, mesmo que para uso domiciliar. Além do mais, deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual. Incidência dos arts. 47 e 51, IV, § 1°, II, do CDC. IV. Portanto, mostra-se abusiva a negativa de cobertura do tratamento com o medicamento em questão. V. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083628214, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 15-04-2020 - grifei).*

No mais, acerca da alegação defensiva da taxatividade do rol de procedimentos da ANS, tem-se que o rol da Agência Nacional de Saúde é meramente exemplificativo, tanto nos julgados acima mencionados, como *in verbis:*

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MENOR ACOMETIDO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO, HIPERATIVIDADE E DIFICULDADE DE APRENDIZADO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA COM TESTE WISC. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2. A falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo procedimento, no rol da ANS, não representa a exclusão tácita da cobertura contratual.3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp nº 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/ 6/2020, ***reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.****4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1876786/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020 - grifei)*

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PREFACIAIS RECURSAIS REJEITADAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PARALISIA CEREBRAL. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODOS BOBATH E PROTOCOLO PEDIASUIT, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E TREINADOR DE MARCHA. COBERTURA DEVIDA. 1. É DE SER AFASTADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUANTO O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA E A ELE INCUMBE DECIDIR SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DE SUA PRODUÇÃO (ART. 370 DO CPC). ASSIM, PODE INDEFERIR A PRODUÇÃO DE PROVA SE ENTENDER PRESCINDÍVEL PARA O SEU CONVENCIMENTO, EM RAZÃO DE EXISTIREM OUTRAS PROVAS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO. 2. NO QUE CONCERNE À PREFACIAL DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, TEM-SE QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO, DEVENDO SER MANTIDO O VALOR DA CAUSA FIXADO EM SENTENÇA, EQUIVALENTE A UMA PRESTAÇÃO ANUAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 292, § 2º, DO CPC 3. NO MÉRITO, CUMPRE REFERIR QUE NÃO HÁ MAIS DÚVIDA QUANTO À APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS DE SEGUROS E DE PLANOS DE SAÚDE, EXCETO NOS PLANOS DENOMINADOS DE AUTOGESTÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA 608 DO E.STJ. NÃO OBSTANTE, TAL EXCLUSÃO DE INCIDÊNCIA NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DOS DITAMES GERAIS DO DIREITO CONTRATUAL, PRINCIPALMENTE A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE, A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ (SUBJETIVA E OBJETIVA) E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. 4. AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR PLANOS DE SAÚDE SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E TAMBÉM NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI. NÃO OBSTANTE, EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10. 5. NO PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, ***O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE PUBLICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR É TÃO SOMENTE REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NÃO POSSUINDO CARÁTER TAXATIVO.*** *6. RESSALTE-SE, OUTROSSIM, QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, É FACULTADO AOS PLANOS DE SAÚDE ESTABELECEREM PARA QUAIS PATOLOGIAS IRÃO OFERECER COBERTURA; NO ENTANTO, NÃO PODEM LIMITAR O TRATAMENTO, POIS ESTE CABE SOMENTE AO MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE SEGURADO, CONHECEDOR DAS PECULIARIDADES DE SEU QUADRO CLÍNICO. 7. EM FACE DE TAIS CONSIDERAÇÕES, SENDO INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, BEM COMO HAVENDO LAUDO MÉDICO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DO TRATAMENTOS POSTULADOS NA EXORDIAL, TEM-SE COMO DEVIDO O FORNECIMENTO DOS ALUDIDOS TRATAMENTOS, SOBRETUDO PORQUANTO CONCERNENTE À PATOLOGIA INCONTROVERSAMENTE COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE (PARALISIA CEREBRAL, CID G80). DESTARTE, AFIGURA-SE IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DO DEVER DE COBERTURA. 8. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, EM ATENÇÃO AO PRECONIZADO PELO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO DESPROVIDO. (TJRS, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014422-66.2019.8.21.0001, 5ª Câmara Cível, Desembargadora LUSMARY FATIMA TURELLY DA SILVA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 28/10/2020 - grifei)*

PELAÇÃO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CAPECITABINA. USO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE. Incide o Código de Defesa do Consumidor à Espécie (Súmula nº 608 do Stj), por se Tratar de Típico Contrato de Adesão, o Que Possibilita A decretação da Nulidade das Cláusulas Que "Estabeleçam Obrigações Consideradas Iníquas, Abusivas, Que Coloquem o Consumidor em Desvantagem Exagerada, Ou Seja, Incompatíveis Com a Boa-fé Ou a Equidade", Bem Como Que as Cláusulas Contratuais Devem Ser Interpretadas de Maneira Mais Favorável ao Consumidor, Nos Termos do Artigos 6º, v, 47 e 51,

iv, do Referido Diploma. "A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico ou hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato" (REsp 183.719/SP). O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, bem como bem como o número de sessões, pois tal incumbência é do profissional que assiste o paciente, a quem compete avaliar os riscos e benefícios do tratamento e indicar a alternativa mais adequada (STJ, Resp nº 668.216-SP, j. 15.03.2007). ***O rol de procedimentos previsto nas normas da ANS não é taxativo, traduzindo somente um referencial de coberturas básicas para os planos de saúde.*** *Os planos de saúde devem incluir em sua coberturas os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. Art. 21, XI, da RN 428/2017, da ANS. No caso dos autos, o laudo e a prescrição médica acostados à inicial atestam que a autora tem diagnóstico de Neoplasia maligna da mama e necessita do tratamento com o medicamento Capecitabina. Sentença mantida. Fixação de honorários recursais. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (TJRS, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011376-69.2019.8.21.0001, 6ª Câmara Cível, Desembargadora DENISE OLIVEIRA CEZAR, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 22/10/2020) (Grifei)*

Não bastasse a argumentação supra, em que pese tenha sido revogada a liminar deferida por este juízo, observa-se que, apesar de o medicamento aqui em discussão não constar no rol da ANS, o mesmo é amplamente recomendado em consultas realizadas junto ao e-Natjus (portal eletrônico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário), em casos idênticos ao aqui em discussão (pesquisa disponível em **https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php**)

Além disso, muitas das recomendações supracitadas mencionam como fundamentação o Relatório de Recomendação nº 335, de janeiro/2018 da Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS), que refere (páginas 32/33 e 37 – disponível em **http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Relatorio_Enoxaparina_Gestantes_Trombofilia.pdf**):

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

(...)

As evidências elencadas nesse relatório demonstram superioridade da enoxaparina em relação ao AAS para o maior número de nascidos vivos, e, consequentemente menor taxa de abortos, entre as gestantes trombofílicas. No que diz respeito aos eventos adversos, sobretudo a ocorrência de hemorragias, não se observa diferença entre as alternativas.

(...)

Dentre as agências internacionais que avaliam tecnologias em saúde, apenas o NICE recomenda o uso da enoxaparina por gestantes trombofílicas, em âmbito hospitalar. Destaca-se que a bula da enoxaparina não possui indicação para o uso em mulheres gestantes e apresenta categoria de risco C na gravidez. O uso off-label da enoxaparina para profilaxia do TEV em gestantes, entretanto, já está consolidado na prática médica, representando um grande impacto financeiro para os Estados e municípios, que acabam fornecendo a medicação por meio de demandas judiciais ou por meio de inclusões em suas listas de medicamentos de maneira independente.

(...)

12. DELIBERAÇÃO FINAL

Os membros da CONITEC presentes na 62ª reunião ordinária, no dia 07 de dezembro de 2017, deliberaram, por unanimidade, recomendar a incorporação da enoxaparina sódica 40 mg/0,4 mL para o tratamento de gestantes com trombofilia.

Destarte, devida a cobertura do tratamento pela ré.

DIANTE DO EXPOSTO, e, para os fins do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo **PROCEDENTE** a ***AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA*** ajuizada por **VICTORIA ROCKENBACH CHIMENDES** em face de **UNIMED VALE DO TAQUARI E RIO PARDO** para **CONDENAR a parte ré no fornecimento da medicação Enoxaparina 40mg** para o correto enfrentamento da doença de que a parte autora é portadora.

Outrossim, arcará a ré com o pagamento das despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao procurador da parte autora, cujo montante, em atenção ao artigo 85, do CPC, fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **CARMEN LUIZA ROSA CONSTANTE, Juíza de Direito**, em 22/6/2022, às 16:53:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10020584842v4** e o código CRC **82e29e92**.

---

1. SÚMULA n. 608 - STJ - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. ↩
2. Art. 422. CC - Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. ↩